PROTOCOLLO 28

Distrazione con apertura progressiva

Aumentare il range articolare combinando distrazione e apertura

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Ipomobilità capsulare	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Ipomobilità capsulare cronica
- ✓ Apertura inferiore a 35 mm
- ✓ Rigidità dopo immobilizzazione

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra su un cuscino basso, muscolatura rilassata, bocca leggermente aperta.

Fisioterapista: dal lato opposto all'articolazione da trattare, guanto monouso, pollice sui molari inferiori omolaterali, dita esterne sul corpo della mandibola; l'altra mano stabilizza il cranio sulla regione temporale.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Posizione

Bocca aperta fino al limite confortevole.

2



FASE 2

Distrazione

Applica distrazione caudale in questa posizione.

3



FASE 3

Apertura

Chiedi una leggera apertura attiva mantenendo la distrazione.

4



FASE 4

Nuovo limite

Ripeti partendo dal nuovo range ottenuto.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	5 a 8
Tenuta	5 secondi
Serie	2 a 3

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Usa il nuovo range con esercizi attivi
- ✓ Procedi in modo graduale
- ✓ Registra l'apertura a ogni serie

Errori da evitare

- ! Forzare il limite in un'unica seduta
- ! Ignorare il dolore riferito all'orecchio
- ! Saltare la stabilizzazione

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura con abbassalingua	Aumentare gradualmente il numero di abbassalingua tra gli incisivi	5 minuti, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Le restrizioni capsulari richiedono stimoli ripetuti e costanti nel tempo.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.